

INTÉRÊT DU BILAN IMMUNO-HÉMATOLOGIQUE DANS LE DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE DE LA MALADIE HÉMOLYTIQUE DU NOUVEAU-NÉ PAR INCOMPATIBILITÉ FOETOMATERNELLE ABO

KESSAL Fatma (1), KADDACHE Salim (1), Sismail Nedjma (1)
(1): Service d'Hémodiologie et Transfusion Sanguine au CHU de Tizi-Ouzou
Auteur correspondant: fatmakessal@gmail.com

Introduction

La MHNN par incompatibilité ABO est la plus fréquente des maladies hémolytiques néonatales d'origine immune. Silencieuse pendant la grossesse, elle se révèle à la naissance par un ictère précoce pouvant évoluer dans les cas graves vers un ictère nucléaire aux séquelles irréversibles.

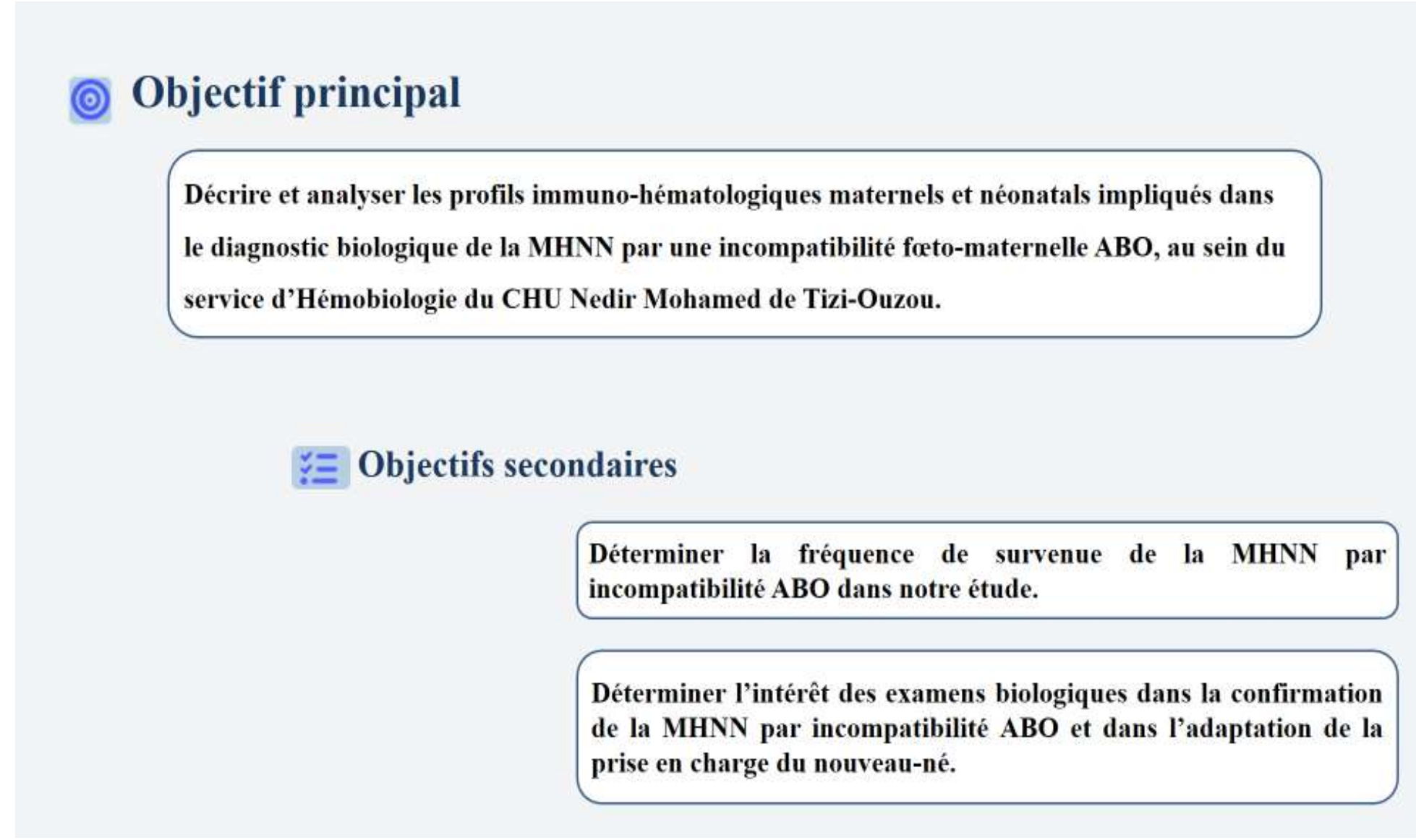
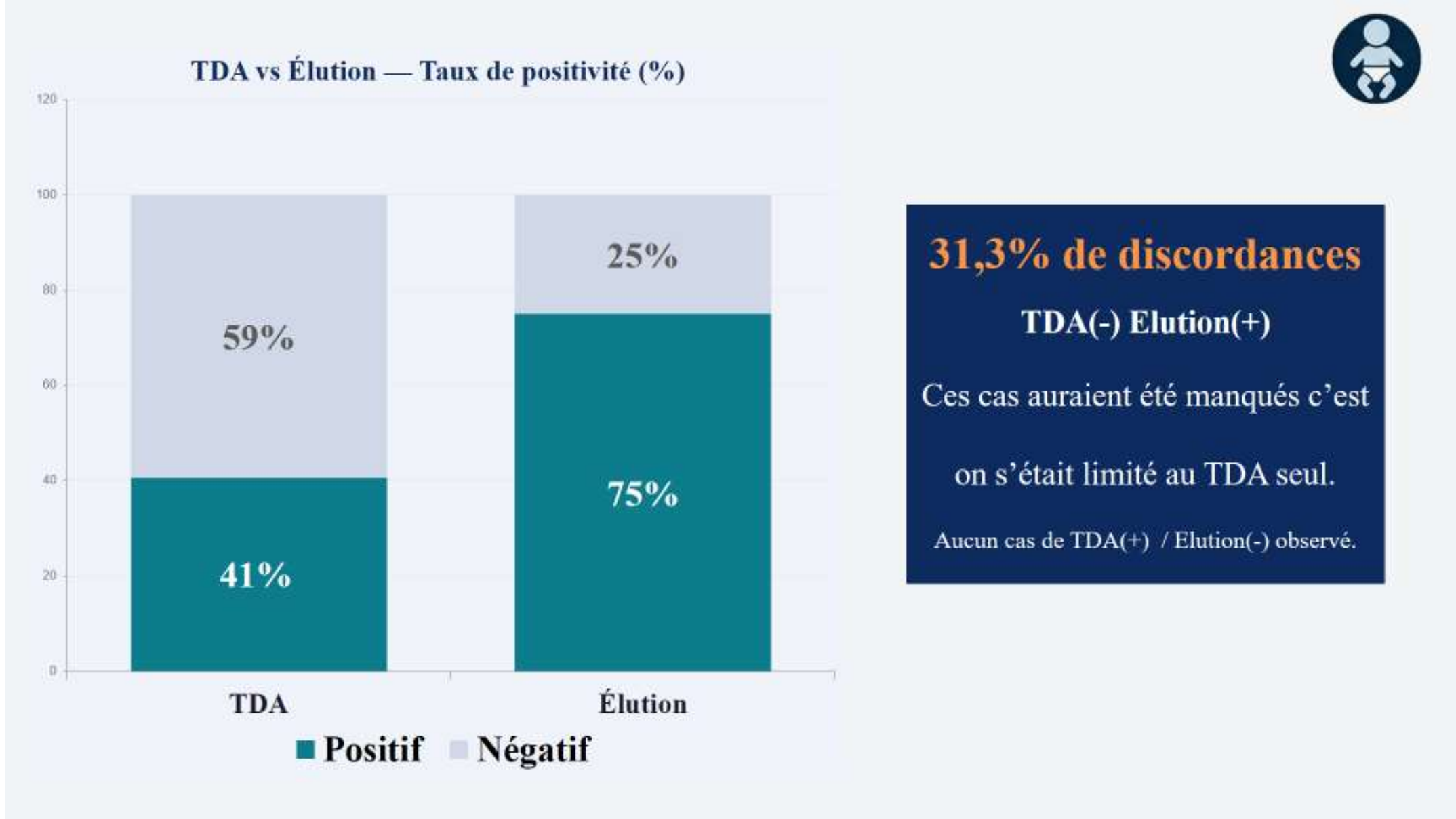
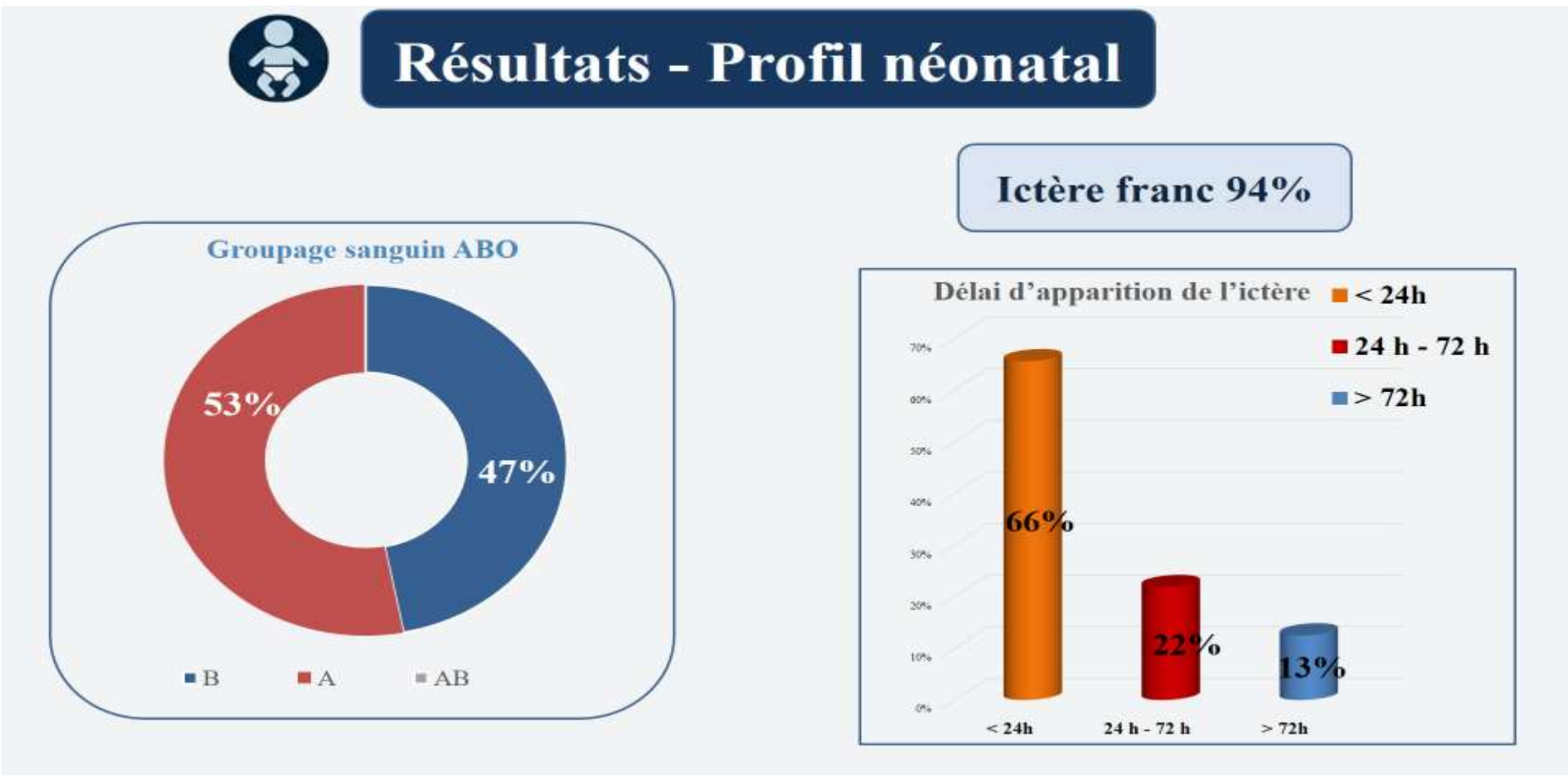
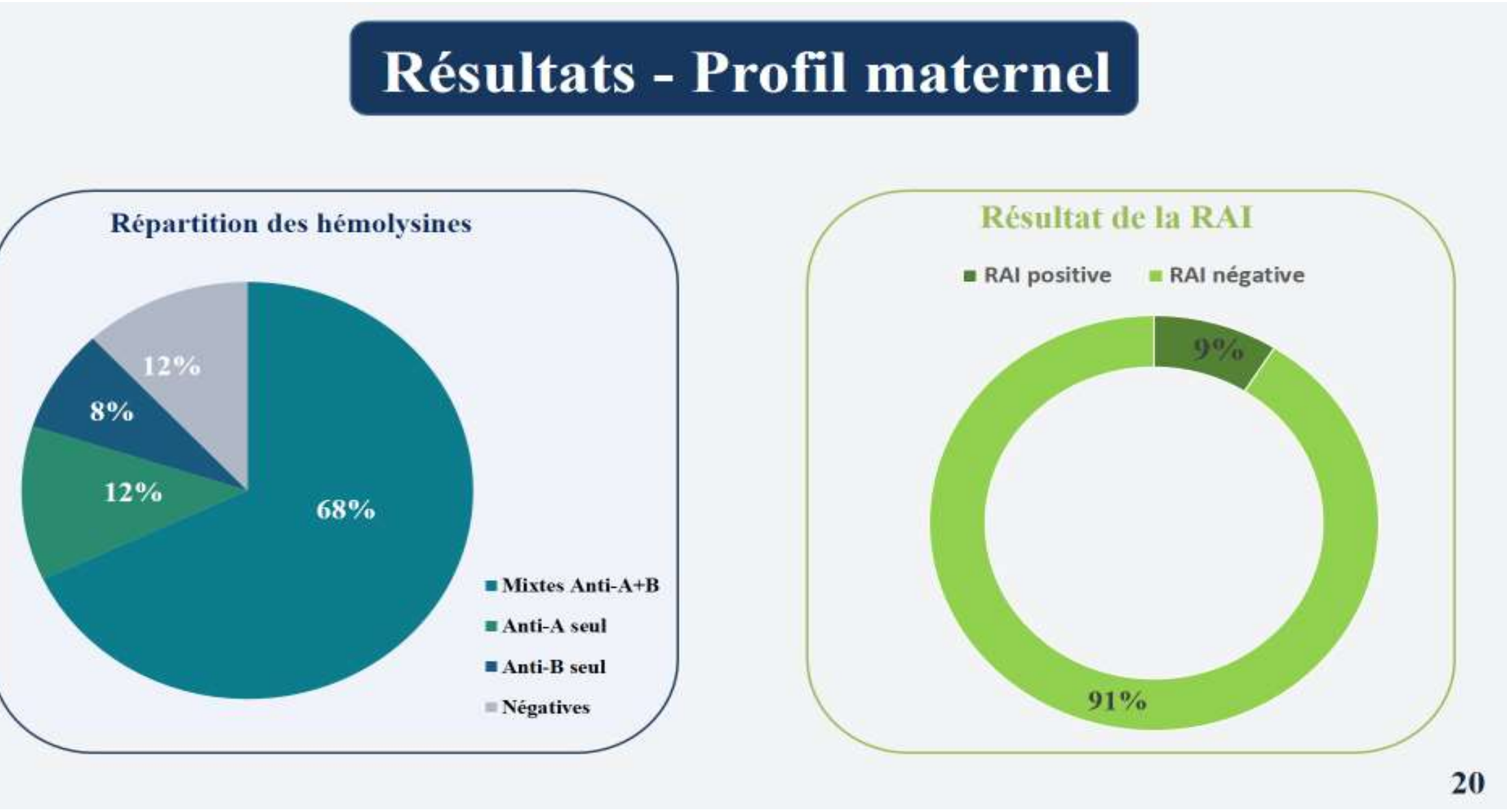
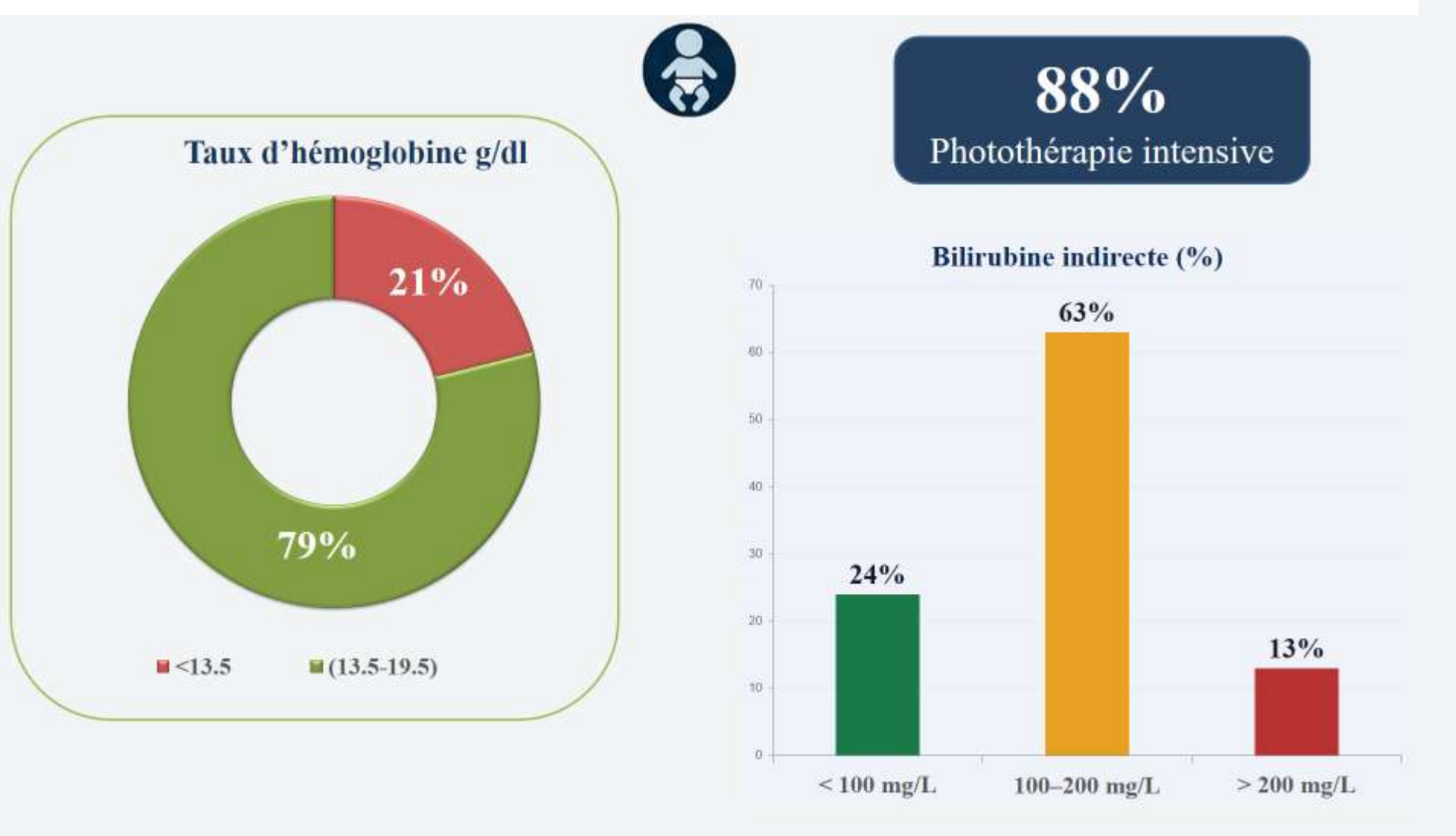
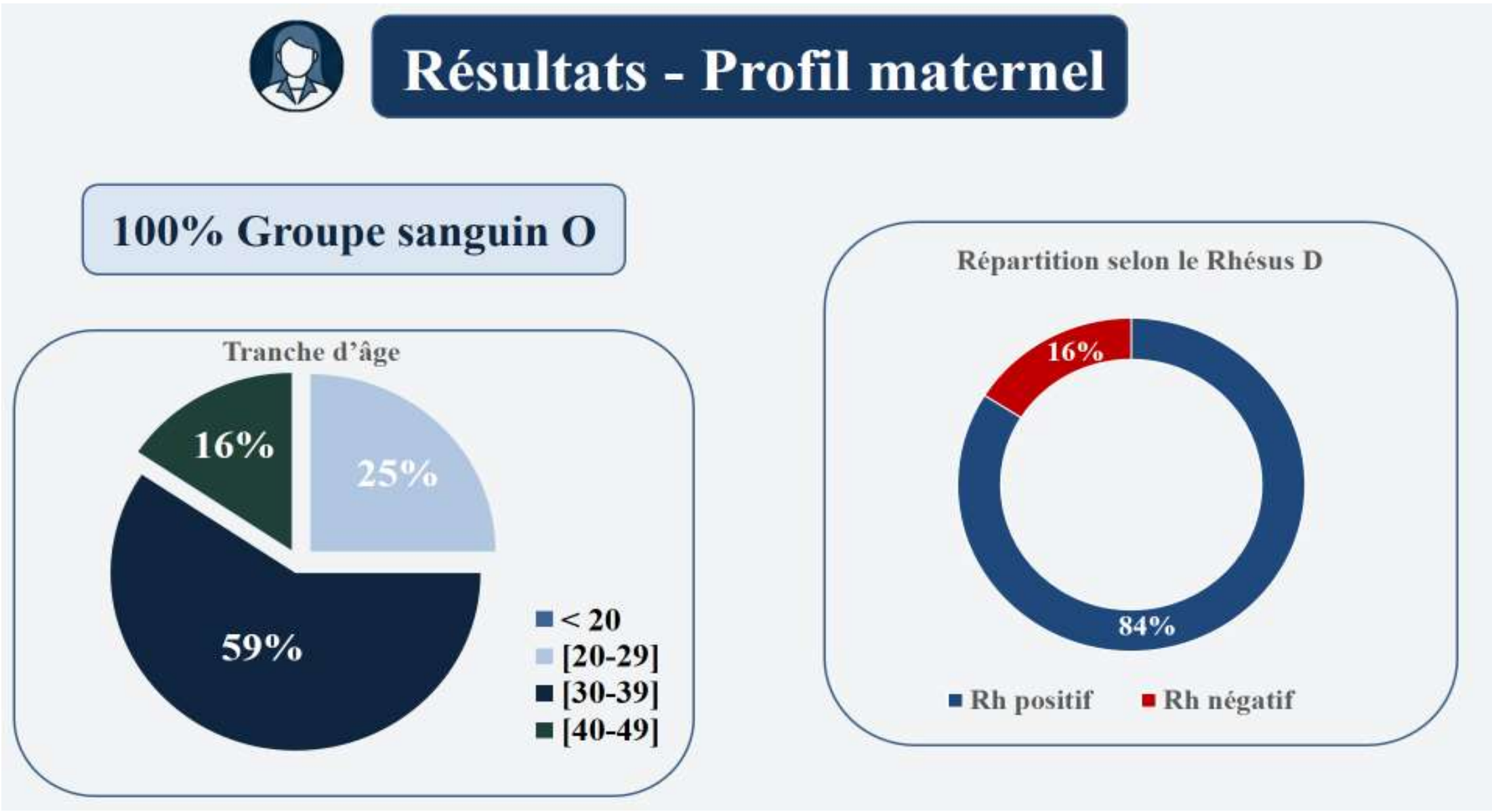
C'est là qu'intervient le bilan immuno-hématologique : confirmant l'origine immune de l'hémolyse, identifiant l'anticorps en cause et orientant la prise en charge.

Problématique

- Malgré sa fréquence, cette pathologie reste difficile à diagnostiquer.
- La discordance entre la sévérité clinique et les résultats biologiques constitue un véritable piège, pouvant retarder la prise en charge et exposer le nouveau-né à des complications graves.

Quel est l'impact du bilan immuno-hématologique dans le diagnostic biologique de la MHNN par incompatibilité ABO et dans l'orientation de la prise en charge thérapeutique ?

Résultats



Cadre méthodologique:

- Type d'étude: Etude descriptive rétrospective et prospective.
- Lieu de l'étude: Laboratoire d'hémodiologie du CHU TIZI-OUZOU, unité immuno-hématologie.
- Critères d'inclusion:
 - Nouveau-nés A, B ou AB nés de mères O avec ictère suspect d'incompatibilité ABO.
 - Dossiers complets avec bilans immuno-hématologiques disponibles.

N=32
Couples mère-nouveau-né

Décembre 2025 - Mars 2026.

Discussion des résultats

Bilan biologique maternel

- La RAI était négative dans 91 % des cas, résultat concordant avec Amrouz & Amanzougaren (2023) (88,57 %) et Amazouz et al. (2022) (96,10 %).
- Les hémolysines maternelles étaient positives dans 88 % des cas, avec une prédominance des formes mixtes Anti-A et Anti-B (68 %), ce qui rejoint les données de Amrouz (65,96 %), Amazouz (62,07 %) et Bigot et al. au Bénin (72 %).

TDA, élution et croisement des résultats

- L'analyse combinée du TDA et de l'élution a révélé une concordance positive (TDA+/Élution+) dans 43,7 % des cas et une discordance de 31,3 % toujours en faveur de l'élution, soulignant sa sensibilité supérieure — résultat comparable à Amrouz (2023) qui rapportait 24 % de discordance.
- Le croisement hémolysines/élution a identifié une concordance positive dans 65,6 % des cas et des discordances globales de 21,9 %, en accord avec les 70 % de concordance positive rapportés par Amrouz.

Bilan néonatal et évolution

- Une survenue précoce d'ictère a été observée dans 66 % des cas.
- La bilirubine indirecte se situait entre 100 et 200 mg/l chez 63 % des nouveau-nés (ictère modéré), et supérieure à 200 mg/l chez 13 % d'entre eux, représentant un risque accru d'ictère nucléaire.
- La majorité des nouveau-nés (79 %) présentaient une hémoglobine normale, bien qu'une anémie ait été retrouvée dans 21 % des cas.
- L'évolution était favorable sous photothérapie intensive dans 88 % des cas.

Conclusion

L'incompatibilité fœto-maternelle ABO représente une cause majeure de la MHNN et d'ictère néonatal précoce. Face à cette pathologie, aucun test biologique isolé ne suffit à confirmer le diagnostic. C'est la combinaison des examens maternels et néonataux, intégrée aux données cliniques, qui permet d'aboutir à un diagnostic fiable et d'assurer une prise en charge thérapeutique précoce et adaptée.